

INDICADO POR: Internet

ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS

MARCOS VENICIO MENDONÇA

IDADE: 57 PESO: 136 ALTURA: 186 PROFISSÃO: Empresário (Ex militar) Aposentado
 SINTOMAS: Roncos, sonolência diurna

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Spirolactone / medicamentos HAS

MÉDICO: Dra. Lilian Christian (Otorino)

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: não realiza

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: JANTAR: 20h-20:30h

HORA QUE DORME: 22:30-23h HORA QUE ACORDA: 5:30-6h

COCHILHO () S () N DORME ACOMPANHADO: (X) S () N (X) EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S (2) X NA SEMANA () N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: 12 anos

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal

BANHEIRO/NOITE: 2x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: 94cm

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI: IV

IAH: 86.2cm SPO2: 55%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: HAS

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA

(N) NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N

SPO2 C/ CPAP:

PRESSÃO NO EXAME:

14/11/24 Avaliação Locação

21/11/24

Pmedia: 13,1 cmH₂O

TAH = 3,6 e/h

m de uso: 5h 27'

fuq: 62.1/m

Oriento que seria ideal

mudar p/ BiPap por um

peto não necessito e

solicitar ficar c/ equipamento

mais 15 dias

Natasha

11/12/24 $P = 13,4 \text{ cmH}_2\text{O}$
 $IAH = 2,5 \text{ e/h}$
fuga: $8,0 \text{ l/m}$
mde wo: $5 \text{ h } 23'$

Oriento fazer Biologia

Natasha

07/03/25 Realizo a leitura de Biologia (Resultado)
com pote

$P = 13,4 \text{ cmH}_2\text{O}$

Bem adaptado

$IAH = 1,6 \text{ e/h}$

mde wo: 7 h

fuga: $23,4 \text{ l/m}$

Natasha

26/05/25 $P = 13,4 \text{ cmH}_2\text{O}$

Bem adaptado.

$IAH = 1,1 \text{ e/h}$

mde wo: $7 \text{ h } 20'$

fuga: 23 l/min

sem compen. baixo

Silvia

Nome: MARCOS VENÍCIO MENDONÇA

Data de Nascimento: 7-5-1967

IMC: 27,22

Sexo: Masculino

Data do exame: 30-08-2021

Peso: 130 kg

Altura: 1,85 m

Médico: DRA. LILIAN CHRYSTIAN G.

MARSON

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 30-08-2021, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 430,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 6,5 e 114,5 minutos. O tempo total de sono foi de 361,5, eficiência de 83,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,7%; estágio N2: 79,0%; estágio N3: 0%; sono REM: 17,3%. O índice de despertares foi de 59,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 86,2/hora, sendo elas 73 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 29 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 55%, permanecendo 72,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 42 - 76 bpm e NREM de 39 - 80 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (1), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. estágio N3 do sono NREM ausente, porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 86,2/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=55%);
5. latências para o sono normais;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Obs.: não houve atividade em EMG sugestiva de bruxismo e não associado a eventos respiratórios.

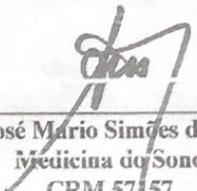
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57